

照护员协作专业答复

生成时间：2026-05-29 19:22:44

照护协作建议报告：陈萍忠女士（上海籍失智老人）

一、问题归纳

1. ****行为抗拒****：老人存在阿尔茨海默病相关BPSD症状，明确拒绝传统康复训练，影响功能维持。
2. ****高跌倒风险****：近期发生右额部皮下血肿，合并体位性低血压、行动能力下降及夜间频繁离床（近3日离床4-9次/晚），浴室洗澡需协助，环境安全防护不足。
3. ****用药管理隐患****：联用多奈哌齐、美金刚、奥氮平、劳拉西泮等多种精神科与慢病药物，存在重复录入、名称错误及潜在相互作用风险。
4. ****家属焦虑突出****：家属照护意愿强但长期处于焦虑状态，需增强信任与参与感。

二、处理步骤（可执行建议）

（1）基于喜好的非药物干预方案（替代康复训练）

- ****将“跳舞”转化为结构化活动****：
 - 每日上午康乐活动时段（原安排基础上）增设15-20分钟“怀旧舞蹈时光”，播放老人熟悉的沪剧、老歌伴奏，鼓励站立轻舞或坐姿手部律动；
 - 若老人抗拒集体活动，可改为一对一陪伴式舞蹈互动，由照护员牵手引导简单步伐，强调“一起玩”而非“训练”；
 - 下午可安排音乐聆听+节奏拍打（如沙锤、鼓），维持运动协调性。
- ****避免强制参与****：若老人当日情绪不佳，不强行推进，转为散步或园艺等低刺激活动，保持正向体验。

（2）24小时防跌倒闭环管理

- ****夜间重点防护****：
 - 实施“夜间如厕全程陪护”：老人有夜间离床习惯（近3日平均离床6次以上），需照护员在床边值守或使用离床感应垫联动呼叫；
 - 床旁至卫生间路径确保无障碍、防滑、照明充足（建议安装感应夜灯）；
 - 卫生间加装L型扶手、防滑垫，淋浴椅固定稳妥。
- ****日间防护****：
 - 起身遵循“坐30秒→站30秒→行走”原则，监测体位性低血压；
 - 洗澡时必须两人协助（一人递物、一人保护平衡），水温控制在38-40℃，避免烫伤。

（3）用药规范落实

- ****立即启动药师审查****：
 - 整理当前用药清单（含多奈哌齐、美金刚、奥氮平、劳拉西泮、振源片等），提交药师核查

重复项（如“多瑞磷脂酰胆碱胶囊”疑似重复录入）、剂量合理性及相互作用；

- 统一药品名称，制作图文版服药卡（含药片照片、服用时间、目的）。

- **服药执行**：

- 每次服药由两名照护员双人核对，记录实际服用情况；

- 观察服药后反应（如嗜睡、步态不稳），尤其晚间服用劳拉西泮后加强看护。

三、风险防护要点

| 风险类型 | 防护措施 |

|-----|-----|

| **跌倒/外伤** |

夜间全程陪护如厕；浴室防滑改造；避免单独行走；起搏器区域避免碰撞 |

| **药物不良反应** |

清理重复用药；监测白细胞/血小板（历史提示偏低）；观察锥体外系反应（奥氮平） |

| **BPSD激惹** |

不否定、不争辩；用兴趣转移注意力；保持环境安静、光线柔和 |

| **睡眠紊乱** |

固定作息，避免午后长时间卧床；晚间减少液体摄入；非必要不使用安眠药 |

四、家属沟通策略

- **主动沟通频率**：每周至少1次结构化沟通（电话或面谈），通报干预进展。

- **沟通内容建议**：

- “我们发现陈阿姨特别喜欢跳舞，现在把康复动作融入她熟悉的旋律中，今天她跟着《天涯歌女》摆手笑了，这是很好的信号。”

- “为了预防再次跌倒，我们加强了夜间陪护，也请您放心，她的起搏器区域我们会特别注意保护。”

- “用药清单正在请药师审核，下周会和您确认最终方案，确保安全有效。”

- **邀请参与**：鼓励家属提供老人年轻时喜爱的歌曲清单，或录制家庭舞蹈视频用于怀旧疗法，增强情感联结。

五、反馈要点（照护员每日记录）

1.

舞蹈/音乐活动参与情况：是否参与、持续时间、情绪反应（愉悦/烦躁/拒绝）；

2. **跌倒相关事件**：离床次数、是否陪护、有无失衡或跌倒；

3. **用药执行**：是否按时服药、有无漏服/拒服、服药后异常表现；

4. **家属互动反馈**：家属提出的问题、情绪变化、合作意愿；

5. **睡眠质量**：实际睡眠时长、夜间觉醒原因（如如厕、找人、不安）。

> 注：本建议基于最新照护现场描述及历史图谱证据生成，未包含无依据推测。请照护员结合当日实际情况灵活调整，并及时更新老人动态。